

与深层的病变不能明确诊断,容易误诊或漏诊,需进一步活体检查。

电子胃镜:内镜检查是现在诊断方法中比较常用的方法,可直接观察病灶,能对食管-胃底的全程进行观察,如果发生静脉曲张可直接观测到曲张的程度和范围,伴出血时,可同时介入止血,诊断与治疗同时进行,避免重复手法对患者造成的伤害。

其内镜下特点是,静脉曲张在食管部位,形态呈条索、串珠隆起,在食管周围群状分布,呈蓝色(青色),如果静脉曲张在胃底,形态呈团块样,一般位置较深,所以镜下检查时,因为色泽相似,容易漏诊误诊^[5]。

内镜检查下,可根据隆起组织与黏膜的关系、部位、程度进行分类,方法如下^[6-10]:Ⅰ级患者,镜下可见曲张静脉团块的直径小于2mm,颜色较深,为蓝色,扭曲呈轻度;Ⅱ级患者,镜下可见曲张静脉团块的直径在2~3mm之间,蓝色或青色,形态为呈不规则线状或盘曲的s状;Ⅲ级患者,镜下可见明显隆起,直径在3~4mm,表面粘膜较好,呈蓝色或紫色,曲张迂曲;Ⅳ级患者,镜下可见曲张团块的直径大于4mm,蓝色,明显迂曲,粘膜残缺;Ⅴ级患者,镜下可见葡萄串状曲张,甚至食管腔被阻塞,红色,粘膜薄。静脉曲张是一种发展比较迅速的疾病,所以应尽力在发展初期控制,并每年复查。这是相对比较先进的方式,缺点是胃镜进入体内的过程难以接受,优点是显影清除,并能观测实时动向。

讨论

食管胃底静脉曲张破裂出血,主要的诱发原因是肝硬化引起的溃疡、糜烂或出血,早期诊断对疾病的控制有积极的意义,诊断方法从最初的X线钡餐到普通超声,再到彩色多普勒超声,及至现在内镜检查,从诸多资料看,内镜检查是现在比较先进的方法,能明确诊断出血情况,但前提条件是,患者非处于出血活动期,即血流动力学相对较稳定。在此情况下,对出血位置、出血量的判断,与病理结果比较吻合^[11-13]。食管至胃底的静脉在解剖位置分为三部分,即食管部位的颈段、胃体部分的胸段和胃底部分的腹腔段,颈段静脉中的血液在循环中,回流至甲状腺下静脉,上胸段静脉中的血液在循环中,回流至奇和半奇静脉,回上腔静脉,重新进入体循环,下胸段的静脉和腹腔段的静脉在移行过程中,与胃左静脉渐次吻合,并入门静脉,共同形成门静脉丛,然后经奇静脉回流,进入上腔静脉重新进入体循环^[16-18]。在生理上,食管部分由于肌肉层较薄,周围无组织支撑,所以缺乏弹性,静脉壁薄,在进入胃部,逐渐静脉壁增厚,弹性增强,但肝门部位的静脉(门静脉)因位置特殊,处于从薄到厚的管壁移行部位,而且受血流压力的影响,所以此处是发生破裂出血等病的高发区,门静脉扩张,得不到缓解,形成不可逆转的静脉曲张,发生破裂出血^[18-20]。

综上所述,对于食管胃底静脉曲张出血患者,根据患者自身情况,尽量选择更适合的检查方式很重要,能早期发现病情,及时治疗,早日恢复健康。

参考文献

- 1 杨舒萍,王康健,沈浩霖.超声造影对食管胃底静脉曲张的诊断价值[J].中华医学超声杂志,2010,7(9):1497-1503.
- 2 黄厚章,谢伟.肝硬化门静脉高压性胃病的诊治(附136例临床分析)[J].中外医疗,2012,31(23):79-81.
- 3 宋瑛.肝硬化食管胃底静脉曲张的诊治进展[J].中华消化病影像学杂志,2012,2(1):55-58.
- 4 魏方.老年上消化道出血96例临床分析[J].临床误诊误治,2007,20(7):67-68.
- 5 明建中,张雪林,沈比先,Glubran-2胶栓术治疗门静脉高压食管胃底静脉曲张[J].山东医药,2012,52(42):58-61.
- 6 Raffi L, Simonetti L, Cenni P, et al. Use of Glubran 2 acrylic glue. in interventional neuroradiology[J]. Neuroradiology, 2007, 49(10): 829-836.
- 7 在波,李征然,钱结胜,等.以NBCA栓塞治疗门脉高压性上消化道出血[J].介入放射学杂志,2007,16(10):661-664.
- 8 苏兰菊,黄雄然,王其珍.门脉高压并食管胃底静脉曲张出血的治疗近况[J].临床荟萃,2002,17(6):367-371.
- 9 钟碧波,寇继光,尹小武.内镜下注射组织粘合剂联合普蔡洛尔预防胃底静脉曲张的临床研究[J].中国医药导报,2012,9(12):93-94.
- 10 鹏飞,朱康顺,孟晓春,等. NBCA 栓塞治疗食管胃静脉曲张后门静脉血流动力学变化的定量研究[J].中国医学影像技术,2008,24(3):434-436.
- 11 许春娣.儿童食管胃底静脉曲张的诊断与治疗进展[J].中国小儿急救医学,2007,14(5):375-378.
- 12 陈杰,贾继东.美国肝病学会2007年食管胃底静脉曲张及出血的防治指南要点[J].胃肠病学和肝病杂志,2007,16(6):505-507.
- 13 钟碧波,寇继光,尹小武.内镜下套扎术治疗食管静脉曲张对胃底静脉曲张出血及门脉高压性胃病的术后疗效[J].中国医药导报,2012,9(12):68-69.
- 14 金生.2007年美国肝病学会肝硬化食管胃底静脉曲张及出血诊治指南介绍[J].实用肝病杂志,2008,11(2):73-76.
- 15 韩莹,刘燕敏,廖慧钰,等.无创诊断指标对乙型肝炎肝硬化患者伴食管胃底静脉曲张风险的评估[J].中华肝病杂志,2012,20(2):141-148.
- 16 占国清,朱琳,谢杏榕.垂体后叶素联合硝酸甘油治疗食管胃底静脉曲张出血的疗效观察[J].临床消化病杂志,2008,21(1):46-50.
- 17 中华医学会肝病学分会,中华医学会感染病学分会.慢性乙型肝炎防治指南(2010年版)[J].中华肝脏病杂志,2011,19(1):13-24.
- 18 石贵福.乙型肝炎肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血39例预后分析[J].中国医药导报,2009,6(26):148.
- 19 Castéra L, Le Bail B, Roudot - Thoraval F, et al. Early detection in routine clinical practice of cirrhosis and oesophageal varices in chronic hepatitis C: comparison of transient elastography (Fibro Scan) with standard laboratory tests and non-invasive scores[J]. JHepatol, 2009, 50: 59-68.
- 20 陈贻胜.食管胃底静脉曲张的内镜治疗[J].临床内科杂志,2004,21(5):291-295.

神经性吞咽障碍的康复治疗及进展

陆红宇

首都医科大学 北京 100000

【摘要】一般脑部有损伤的病人都会在吞咽时感到有障碍,为了改善病人在吞咽时的困难,本文对治疗吞咽时障碍症状的办法做了归纳,如下所示:改变病人吞咽食物的物理特性以及形状;训练吞咽部位的肌肉以及病人面部在康复中的功能,其中有进食方面的锻炼、对感觉神经的刺激、对呼吸功能的锻炼、对吞咽时的技巧的锻炼、对面部或者口部的肌力所做的锻炼;对病人在吞咽时的体位做出调整;中西医结合进行治疗;用针灸的方法治疗;内心的治疗;用手术进行治疗。在我院中治疗吞咽时障碍的症状的办法,主要使用的有基础方面的大范围锻炼和用手术进行治疗。在国外,有很多专门治疗吞咽时障碍的医疗机构,并且用综合体系化的治疗形式帮助病人康复。在国内,帮助病人康复的重担都是由专业医疗人士和护士去协作完成^[1]。

【关键词】神经性; 吞咽障碍; 康复; 治疗; 进展

基础方面的锻炼:在吞咽时有障碍的病人大多是咽喉或者口腔都出了问题,所以在病人在病床中吃东西的时候,身体摆放的样子要根据病情、症状、病人等的不同而不同。在初期让病人做

一些进食方面的锻炼的时候,所选的体位要具备代偿性能和安全性能。若是病人不可以用坐位的情况,要让病人身体处于仰卧的姿势,但是角度不得低于30度,并且头部要成前驱的姿势^[2]。若

是病人有偏瘫的症状,在喂病人吃饭、饮水、吃药等东西时,要用一个枕头垫在病人的肩部,帮助病人实现进食动作的人员要站在病人的一侧。用这种体位,病人进入口腔中的东西不容易流出以及漏出,并且对舌根辅助食物的进入也有利,以防病人因为吞咽错食物或者因为食物逆流进入鼻腔而对生命健康产生威胁。让病人的颈部在吞咽时成前屈的姿势也是防止出现误咽性威胁的体位,由于病人在仰卧的时候,一般颈部都是成后屈的姿势,这时有吞咽的动作,颈椎部位的机体就会呈现紧张的状态,咽喉会有活动障碍,此时就易造成食品误咽^[1]。

通常病人适用的食物有以下5种特性或形状:较稀疏的流质、较浓密的流质、成黏糊形状、凝固性不强、凝固性较强。在治疗吞咽中有障碍的病人时,病人适用的食物特性是成黏糊形状的。但是具体要看病人在吞咽时所呈现的障碍程度来进行适当的配置^[2]。在病人的口腔处于准备的阶段时,当食物被送到空腔中以后,病人若口部在关闭时有困难,并且没有力气咀嚼,这样就阻碍了对吞咽中的病症诊治,因此病人使用的食物必须容易嚼,像比较浓的补汤、苹果泥等,使用的进食工具是注射器、长勺。在之后的时期中,为了不使病人在吸入食物时有呕吐或者错误吞咽的现象,所以病人使用的食物必须特别柔软。等病人到了"咽期"的阶段,吃的事物不能有容易掉碎屑、掉渣的饼干或者糕点,或者内聚力比较弱的东西。等病人到了"食管"期,在此时应让病人吃一些很湿润而且软软、柔柔的东西,不能吃比较干燥而且特别黏的东西^[3]。

用手术进行治疗:用手术进行治疗,主要是用球囊性的导管进行扩张手术,这种手术在操作时比较简单,而且对病人的损伤比较小,对治疗先天性的食管狭窄、消化时的食管狭窄、术后造成的食管狭窄、化学药品造成的食管狭窄等病情很有效果。这种手术分为:不分级的一次性扩张手术、分级的多次性扩张手术。由于病人是脑卒里边的损伤以及脑部放射型的损伤致使病人在吞咽时的机体被破坏。在治疗中,第一策略就是对病人进行局部性的扩张手术^[4]。这类手术通常是由耳鼻喉或者肠胃治疗科的医生进行操刀治疗。过去一直用的手术办法是将直径不一的管子,从病人口腔上部缓缓向下进入,然后用管子扩充病人食管中的机体,促使病人的吞咽机体得到扩张。通过这类手术进行治疗,有的医生觉得手术在短期之内,虽然病人会感到明显的舒适,但是过了较长的时间后,效果就失去了。所以它主要用于病人是良性的食管狭窄,若病人是脑卒之中有损伤造成的食管吞咽机体痉挛,这种手术就不适用^[5]。手术的长期滞后效果就会变差,使食管在术后再次变得狭窄。良性的食管狭窄在经过此类手术后会出现再次变狭窄的根源是病人的细胞核中的纤维以及抗原在与蛋白接触之时会严重分泌。所以要用均匀性、渐进性的形式对病人食管之中的内压进行必要的测量。另外,注意对食管中黏膜的保护等是防止食管再次变狭窄的良方^[6]。

影响因素:对于脑部有损伤致使吞咽东西时会感到障碍的这类病情,若只是让病人做功能方面的锻炼以及食管治疗并不能让病情有所改变,应该让病人进行综合、体系化的锻炼,例如:上肢在帮助进食中的动作锻炼、肌力方面的锻炼、排痰时的锻炼、食物的健康配制、口腔的健康等。因为病人是吞咽时所产生的障碍,所以但凡和食物相连的一切细节在选用时都要谨慎。所以要制定出综合的、体系化的辅助病人康复方案。对于在认知以及心理、视听、语言等方面都有障碍的病人,在治疗吞咽病情时,各治疗科要协调、互补好、合作好,做好一切治疗障碍的措施,帮助病人在吞咽时的障碍以及其它障碍等得到改善^[7]。

小 结

对于脑部有损伤致使吞咽东西时会感到障碍的这类病情,用上述的基本治疗形式:让病人做功能方面的锻炼以及食管治疗。这样并不是最有效的障碍治疗形式,应该让病人进行综合、体系化的锻炼。方法有很多,通过改变病人吞咽食物的物理特性以及形状;训练吞咽部位的肌肉以及病人面部在康复中的功能,其中有对感觉神经的刺激、对呼吸功能的锻炼、对吞咽时的技巧的锻炼、对面部或者口部的肌力所做的锻炼;对病人在吞咽时的体位做出调整;中西医结合进行治疗;用针灸的方法治疗;心理看护;用手术进行治疗等。在我院中治疗吞咽时障碍的症状的办法,主要使用的有基础方面的大范围锻炼和用手术进行治疗。使病人在吞咽时的障碍得到了改善^[8]。

参考文献

- 1 郑丰平,林显艺,梁艳娉,陶力. 经皮内镜下胃造瘘在神经性吞咽障碍患者中的应用 [J]. 现代消化及介入诊疗,2011(4):245~247.
- 2 万桂芳. 神经性吞咽障碍的康复治疗 [J]. 中华物理医学与康复杂志,2011(11):735~736.
- 3 兰月. 神经性吞咽障碍的临床评估 [J]. 中国康复医学杂志,2009,18(6):415~418.
- 4 窦祖林. 神经性吞咽障碍的康复治疗及其进展 [J]. 中华物理医学与康复杂志,2009(11):788~791.
- 5 徐光青. 神经性吞咽障碍的临床评估 [J]. 中国康复医学杂志,2010(5):379~381.
- 6 陈艳,潘翠环,王璇. 神经性吞咽障碍不同浓度钡液吞咽造影检查分析 [J]. 临床医学工程,2010(6):678~681.
- 7 胡明秋. 吞咽训练综合治疗神经性吞咽障碍的研究 [J]. 中国实用神经疾病杂志,2010(6):8~10.
- 8 陈少贞,黄东锋,等. 应用 Rood 技术治疗神经性吞咽障碍 [J]. 中华物理医学与康复杂志,2009(3):180~181.
- 9 谭诚,邓彦,胡明秋. 神经肌肉电刺激联合吞咽训练综合治疗神经性吞咽障碍的研究 [J]. 中国实用神经疾病杂志,2011(5):560~562.
- 10 陈秀丽,杨素烟,郑雅红. 神经性吞咽障碍病人的护理 [J]. 护理研究:中旬版,2009(2):414.

耳鼻喉科学教学改革探索

王晓舟

湖北中医药高等专科学校 湖北 荆州 434020

【摘要】 随着现代医学的发展,其模式已从生物医学的模式向生理~心理~社会的模式转变,耳鼻喉科学在教学及临床中日益受到重视,传统的填鸭式教学方法,偏重医学生获得医学知识,已不能适应新时代耳鼻喉科学教学的要求。耳鼻喉科学是一门注重实际应用的学科,需要结合解剖、生理、病理、内科、外科等各个学科的知识,并且需要把理论知识在实际工作中灵活地运用。这就要求我在教学的过程中要善于激发学生们的积极主动学习的兴趣,培养他们获取知识的能力和技巧。为此我们对耳鼻喉科学的教学进行改革,我们通过带领学生走出理论课堂,把课本知识实践相结合。达到通过实践掌握耳鼻喉科学的目的。

【关键词】 耳鼻喉科学;教学改革;理论与实践结合

耳鼻喉科学改革背景:通过几年的教学工作观察,目前的耳鼻喉科学日常教学中主要有三问题:①耳鼻喉科学在日常的教学中只单纯的开展理论教学,完全忽略了实训教学项目。而且是以教师讲授课为主,而学生们只是处于被动接受状态。理论完

全与临床脱节,从而使学生学起来极其单调乏味,不能牢记所学内容,很难适应实际的临床工作。②在学校每年的举行的社区义诊活动时,学生们很难单独完成老师交待的任务,对一些常见的基本问题不能单独做出判断。③耳鼻喉科学在大专医学类院校